

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

**蒋德铭(男)**

项目号 T022590260

单位 纽泰仑

联系电话 181****2778

项目简称 纽泰仑

员工号

类别 员工

卡号 0021002208262531

部门 喜播事业部

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 7020251126218



上海爱康国宾人人门诊部

检查日期 2025.11.26

45/1622

爱康国宾®

3 6 0 ° 健 康 全 管 理

爱康集团是中国领先的以人工智能驱动的、基于医疗大数据云端服务的数字化健康管理平台。通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老、康复医疗等健康管理及医疗服务。通过爱康智汇康云laaS开放平台，赋能第三方体检与医疗机构，建立起辐射全国主要城市的服务网络，打造“医疗实体+智能云端”的立体化健康管理服务体系。截至2025年7月，爱康集团已在54大城市设有173家体检、齿科与医疗中心。同时，

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	04
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	05
	建议与指导	
3	健康体检结果	07
	检查详细结果	
4	深度咨询或风险评估产品建议	19
	历年指标变化疾病风险评估	
5	健康咨询类项目说明	22
	咨询类项目说明	
6	医学名词科普知识	23
	医学名词科普知识内容	

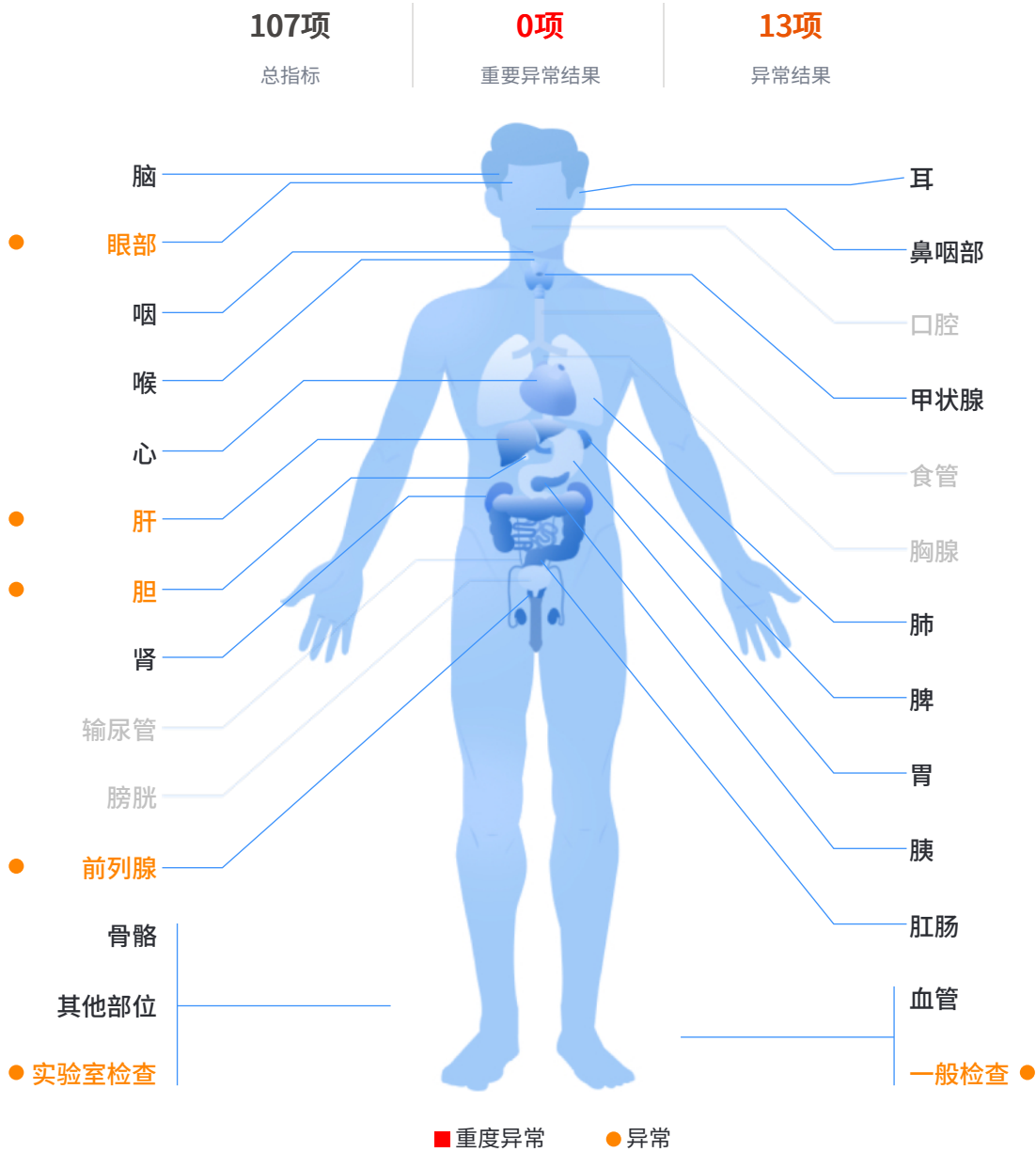
尊敬的蒋德铭 先生，您好！

上海爱康国宾人人门诊部感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2025年11月26日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

- 1.您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
- 2.健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
- 3.您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
- 4.因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
- 5.由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 体重指数增高
- 【2】 血压增高
- 【3】 总胆固醇增高；甘油三酯增高；低密度脂蛋白胆固醇增高
- 【4】 中度脂肪肝
- 【5】 丙氨酸氨基转移酶增高； γ -谷氨酰转移酶增高
- 【6】 血小板分布宽度增高
- 【7】 胆囊壁胆固醇结晶
- 【8】 多发性胆囊息肉
- 【9】 前列腺稍大
- 【10】 屈光不正



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 体重指数增高

- 1、体重指数（BMI）又称为身体质量指数、体质指数，该指标是通过体重（公斤）除以身高（米）的平方计算得来。体重指数（BMI）正常值范围为18.5~23.9，若BMI低于18.5属于体重过轻，体重指数（BMI）增高是指超过23.9，即体重高于正常范围，24.0~27.9为超重， ≥ 28.0 为肥胖。引自：体重管理指导原则（2024年版），《成人体重判定》（WS/T428-2013）。
- 2、体重指数(BMI)是衡量一个人体重与身高之间关系的指标。体重指数偏高可能是饮食结构不合理、运动量不足、睡眠质量差、疾病影响、遗传因素等因素，需要针对病因治疗，可采取的方法有调整饮食、加强运动、改善睡眠、治疗疾病等。当体重指数(BMI)偏高时,可能会引起一系列健康问题，如肥胖、高血压、高血脂、糖尿病等。
- 3、建议咨询医生或营养师，制定个性化改善方案。

02 血压增高

- 1、收缩压 ≥ 140 mmHg和/或舒张压 ≥ 90 mmHg。
- 2、请监测血压，若三次以上非同日测得收缩压 ≥ 140 mmHg和/或舒张压 ≥ 90 mmHg，建议去医院专科确诊。
- 3、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式，戒烟限酒，低脂、低盐、合理膳食，坚持有氧运动，控制体重，减轻精神压力、保持心理平衡等。

03 总胆固醇增高；甘油三酯增高；低密度脂蛋白胆固醇增高

- 1、多项血脂指标异常提示存在脂质代谢紊乱的核心病理机制，主要表现为胆固醇和甘油三酯合成增加、清除减少，导致动脉粥样硬化风险显著增高。
- 2、血脂异常可协同增加心血管事件发生风险，需要关注动脉粥样硬化进展及相应靶器官损害的可能性。
- 3、建议采取综合生活方式干预，包括严格低脂低胆固醇饮食、减少酒精摄入、增加有氧运动锻炼、控制体重并戒烟限酒。
- 4、建议定期复查血脂指标，如持续异常请及时就医进行专业评估和处理。

04 中度脂肪肝

- 1、是体内脂肪在肝脏内蓄积，常因喜食荤食、过量饮酒及肥胖或糖尿病等引起，可造成消化功能异常或肝脏代谢解毒功能的下降，若继续发展，可能会出现肝纤维化或肝硬化。
- 2、每年复查一次血脂，肝功能、肝脏B超；伴有高脂血症应及时到消化内科就诊。
- 3、严格忌酒，避免使用损肝药物；坚持有氧运动，如快步走、慢跑等，促进脂质代谢。
- 4、合理膳食，以低糖、低脂、低盐、高蛋白质、高维生素为原则，少吃油炸煎烤类食物。

05 丙氨酸氨基转移酶增高； γ -谷氨酰转移酶增高

- 1、肝脏酶学指标异常主要反映肝细胞膜通透性改变或胆道系统功能异常，丙氨酸氨基转移酶和 γ -谷氨酰转移酶同时增高提示可能存在肝细胞损伤伴胆道排泄功能受影响，这种改变常见于酒精性肝损伤、药物性肝损伤或脂肪性肝病等病理过程。
- 2、需要关注肝功能持续异常可能导致肝纤维化进展的风险，长期肝酶异常可能影响营养物质代谢和解毒功能。



下载爱康APP
查看彩色报告

- 3、建议戒酒并避免使用可能损伤肝脏的药物，保持饮食多样化并增加优质蛋白质和新鲜蔬菜水果摄入，适当控制体重并规律作息避免劳累。
- 4、建议近期医院专科就诊进行专业评估和处理，根据医生指导定期复查肝功能指标。

06 血小板分布宽度增高

建议定期复查，关注指标变化趋势。

07 胆囊壁胆固醇结晶

建议平时改善生活习惯，用低胆固醇饮食，勿暴饮暴食，如有右上腹和肩背部隐痛及消化不良等症状请专科就医。

08 多发性胆囊息肉

- 1、指胆囊壁上生长出向胆囊腔内突出呈息肉状病变组织，一般多为良性。
- 2、建议到医院肝胆外科，根据医生建议治疗。
- 3、注意饮食规律，减少油腻食物摄入。

09 前列腺稍大

- 1、概述：前列腺是男性特有的性腺器官，由腺体和纤维肌肉组成的腺肌性器官，外有包膜，位于膀胱与盆底之间包绕尿道前列腺部。前列腺大小：正常前列腺横径约4cm，纵径约3cm，前后径约2cm，重18~20g，超出此范围称之为前列腺肥大。
- 2、前列腺增生又称前列腺肥大，年龄的增长是前列腺增生发病的一个重要因素，与高脂饮食、饮酒、吸烟及久坐少运动等因素有关。
- 3、前列腺疾病大多在早期无临床症状，若出现排尿费力、不畅、排尿困难和血尿等症状，建议及时前往医院就诊，在专业泌尿科医师的指导下完善相关检查，查明病因。前列腺检查项目包括直肠指检、前列腺彩超检查、前列腺液常规、前列腺特异抗原等。前列腺特异抗原一般对于前列腺癌的早期筛查有重要意义。
- 4、建议到医院专科诊治、随访。

10 屈光不正

注意用眼卫生，定期眼科随访。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：张为华

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	173.0	cm		
体重	83.4	Kg		
体重指数	27.9		↑	18.5—23.99
收缩压	137	mmHg		90.0—139.0
舒张压	95	mmHg	↑	60.0—89.0
初步意见	1.血压增高 2.体重指数增高			

内科

检查者：翁亚文

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	76	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

眼科

检查者：庄海燕、李祥斌

检查项目	检查所见	单位
------	------	----

裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	1.0	
矫正视力(左)	1.0	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
裂隙灯检查	未见明显异常	
初步意见	屈光不正	

耳鼻咽喉科

检查者： 张宇

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者： 雷程凤 审核者： 朱伶俐

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
------	----	------	----	------	----	------	------	-----

白细胞计数	WBC	4.70		3.5—9.5	10 ⁹ /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞计数	RBC	5.51		4.3—5.8	10 ¹² /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
血红蛋白	Hb	163.0		130—175	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞比容	HCT	0.48		0.4—0.5	L/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
平均红细胞体积	MCV	88.00		82—100	fL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	29.60		27—34	pg	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	337.00		316—354	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	13.50		10—15	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	

血小板计数	PLT	151.00		125—350	10 ⁹ /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
平均血小板体积	MPV	10.40		7—14	fL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
血小板分布宽度	PDW	19.80	↑	10—18	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
淋巴细胞百分比	LYMPH%	32.20		20—50	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
中性粒细胞百分比	NEUT%	58.20		40—75	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.52		1.1—3.2	10 ⁹ /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
中性粒细胞绝对值	NEUT	2.74		1.8—6.3	10 ⁹ /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	46.00		42.8—51	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	

血小板压积	PCT	0.160		0.108—0.282	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
单核细胞百分比	MONO%	7.70		3.0—10.0	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
单核细胞绝对值	MONO	0.36		0.1—0.6	10 ⁹ /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
嗜酸性细胞百分比	EOS%	1.90		0.4—8.0	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.09		0.02—0.52	10 ⁹ /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.00		0—1.0	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0—0.06	10 ⁹ /L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	

小结

血小板分布宽度增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：杨涛 审核者：朱伶俐

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
尿比重	SG	1.015		1.010—1.025		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿酸碱度	PH	7.0		4.5—8.0		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	

尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿镜检红细胞	RBC	0		0—3		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿镜检白细胞	WBC	0		0—5	/HP	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
管型	CAST	0		0	个/LP	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿液透明度	UCI	透明		清		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿液颜色	Colour	淡黄色		淡黄		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	

尿液其它		无		无		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
小结	未见明显异常							

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：张耀 郭思 审核者：刘芳 邓琴琴

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
★ 铁	Fe	563.3		380.8—572.3	mg/L	上海金域医学检验所有限公司	血	
★ 钙	Ca	48.3		46.0—84.0	mg/L	上海金域医学检验所有限公司	血	
★ 铜	Cu	816.1		720.0—1750.0	μg/L	上海金域医学检验所有限公司	血	
★ 锌	Zn	6.1		4.8—9.3	mg/L	上海金域医学检验所有限公司	血	
★ 镁	Mg	41.7		26.4—50.4	mg/L	上海金域医学检验所有限公司	血	
同型半胱氨酸(化学发光法)	Hcy	10.94		0—15	umol/L	上海元化门诊	血	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

生化实验室检测

操作者：王思雨 审核者：李黎明

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
丙氨酸氨基转移酶	ALT	56	↑	0—50	U/L	上海元化门诊	血	
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	28		0—40	U/L	上海元化门诊	血	
γ-谷氨酰转移酶	GGT	124	↑	10—60	U/L	上海元化门诊	血	
碱性磷酸酶	ALP	83		45—125	U/L	上海元化门诊	血	
总蛋白	TP	75		60—85	g/L	上海元化门诊	血	
白蛋白	ALB	46		40—55	g/L	上海元化门诊	血	
球蛋白	GLb	29		20—40	g/L	上海元化门诊	血	
白蛋白/球蛋白比值	A/G	1.59		1.2—2.4		上海元化门诊	血	
尿素	UREA	5.9		3.1—8.0	mmol/L	上海元化门诊	血	
肌酐	Cr	87		57—97	umol/L	上海元化门诊	血	
尿酸	UA	377		210—420	umol/L	上海元化门诊	血	
空腹血糖	FBG	6.06		3.9—6.1	mmol/L	上海元化门诊	血	
总胆固醇	TC	6.02	↑	0—5.2	mmol/L	上海元化门诊	血	
甘油三酯	TG	1.75	↑	0.45—1.7	mmol/L	上海元化门诊	血	

高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.42		0.8—1.8	mmol/L	上海元化门诊	血	
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	4.35	↑	0—3.37	mmol/L	上海元化门诊	血	
脂蛋白(a)	LP(a)	319		0—400	mg/L	上海元化门诊	血	

小结

- 1.总胆固醇增高
- 2.甘油三酯增高
- 3.低密度脂蛋白胆固醇增高
- 4.丙氨酸氨基转移酶增高
- 5.γ-谷氨酰转移酶增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

血管内皮生长因子

操作者：张耀 审核者：刘芳

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
血管内皮生长因子	VEGF	450.20		0—778.62	pg/mL	上海元化门诊	血	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

肿瘤标志物

操作者：王沁颖 审核者：蔡云

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
甲胎蛋白定量	AFP	9.04		0—13	ng/ml	上海元化门诊	血	
癌胚抗原定量	CEA	0.52		0—5	ng/ml	上海元化门诊	血	
糖类抗原242	CA242	1.07		0—20	U/mL	上海元化门诊	血	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

采集者：丁培

检查者：

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律，心率60~100次/分，P波、P-R间期、QRS波群、ST段、T波、电轴、电压等系列指标参数，均在正常范畴内。	
初步意见	未见明显异常	

腹部彩超

检查者：孙洁萌

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态饱满，肝内实质回声细腻，略增强，分布不均匀，后方回声衰减，肝内血管变细，显示欠清晰，CDFI:血流显示正常	
胆	胆囊形态大小正常，胆囊内壁附多个中等回声，最大约5×4mm，不随体位改变而改变； 胆囊壁可见一枚颗粒样强回声，后伴彗星状声影	
胰	胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张.CDFI:血流显示正常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常	
双肾	双肾形态大小位置正常，包膜完整，实质回声正常。CDFI：血流显示正常	
初步意见	1.多发性胆囊息肉 2.中度脂肪肝 3.胆囊壁胆固醇结晶	

前列腺彩超

检查者：孙洁萌

检查项目	检查所见	单位
前列腺	前列腺大小约42×27×29mm	
初步意见	前列腺稍大	

甲状腺彩超

检查者：孙洁萌

检查项目	检查所见	单位
甲状腺	甲状腺形态大小正常，表面光滑，包膜完整，内部回声均匀。CDFI：血流显示正常。	

初步意见

未见明显异常

放射科

检查项目	检查所见	单位
膝关节		

初步意见

未见明显异常

动脉硬化检测室

检查者： 孙志

检查项目	检查所见	单位
动脉硬化检测	CAVI检测值：在正常范围，提示血管弹性良好。 ABI检测值：在正常范围，提示下肢血管未见明显异常。	

男外科

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

评审医师： 谢庚富

主检医师： 刘英华

iKang 爱康



下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.深度咨询或风险评估产品建议

甘预-肝癌早期筛查

肝癌，一般是指原发性肝细胞癌，约占全部原发性肝癌的85-90%，是最常见的恶性肿瘤之一[1]。2020年世界卫生组织最新数据显示，我国肝癌年新发病例约占全球的45.3%，肝癌年死亡病例约占全球的47.1% [2]。

肝癌高居我国癌症死因的第二位，其发生和发展一般会经历一个漫长的过程。由于早期肝癌无明显痛感，早期发现将有助于肝癌的诊断和治疗。

甘预——肝癌全维度超早期筛查管理方案，能够在无症状期发现3cm以下的肿瘤，为有需求的患者提供覆盖全国多家名牌医院的诊疗绿色通道，使患者能够获得及早诊治机会，5年生存率有效提升至80%以上。

甘预所采用的无创液态活检技术，我国首个获得美国FDA“突破性医疗器械”认定的肝癌早期筛查产品，能够比常见的影像学及血清标志物检测更早期发现癌变，该技术获得了权威指南和共识的推荐[3,4]，并建议您每隔6-12个月进行1次检查。（注：对于罹患肝癌的患者，建议前往医院就诊）

参考文献：

[1] Grandhi MS, Kim AK, Ronnekleiv-Kelly SM, et al. Hepatocellular carcinoma: From diagnosis to treatment. Surg Oncol. 2016;25(2):74-85.

[2] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.

[3] 原发性肝癌诊疗规范（2019年版）[J].传染病信息,2020,33(06):481-500.

[4] 陆荫英,赵海涛,程家敏,姬峻芳.肝胆肿瘤分子诊断临床应用专家共识[J].临床肝胆病杂志,2020,36(07):1482-1488.



甘预

爱康关爱您的肝脏健康

扫描右侧二维码购买



扫码购买



下载爱康APP
查看彩色报告

Basis NAD+细胞补充剂

Basis由Elysium Health首席科学家、麻省理工学院衰老研究中心主任Leonard Guarente教授领衔研发。2000年，Guarente教授首次发现长寿因子家族Sirtuins只有被NAD+激活时才能延长酵母寿命的机理[1]，而随着年龄的增长，NAD+水平不断下降。

Basis 含有两种强大的成分来对抗细胞衰老。

1) 烟酰胺核糖 (NR-E)

NAD+ 的高效前体，相比烟酸和烟酰胺，这种前体已被证明能更优先提高 NAD+水平。

2) 紫檀芪 (PT)

一种由植物自然产生的强效多酚，可抵御内部和外部压力。

美国原装进口，保税仓直邮发货

提高并维持NAD+水平在40%[2]

增强细胞能量，维持健康DNA

细胞层面对抗衰老

参考文献：

[1] Doi:org/10.1038/35001622

[2] Doi:org/10.1038/s41514-017-0016-9



Basis NAD+细胞补充剂

可将人体NAD+水平提高40%

扫描右侧小程序码购买



扫码查看

Mosaic 胶原蛋白支持

Mosaic由康奈尔医学院（Weill Cornell Medical College）皮肤系主任Richard Granstein教授指导研制而成。

随着年龄的增长，皮肤会失去弹性和水分，更容易受到环境和内部压力的影响。要保持年轻肌肤，需要从内部推动变化。

Mosaic由类胡萝卜素、生育酚（维生素E）和鼠尾草酸组成的配方，可协同提供强大的抗氧化功效，改善和保护皮肤。

经临床证明，Mosaic可从内层对抗皮肤衰老，补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质[1]。

1) 3周，皮肤水分含量有明显的增加[2]。

12B47C8E69A44B50AD75075C09CB7B1D47E1ACC33BBFC35E67564D63654FCAD2 12B47C8E69A44B50AD75075C09CB7B1D47E1ACC33BBFC35E67564D63654FCAD2

上海爱康国宾人人门诊部

全国统一报告解读专线：400-081-8899

注：★ 自费增项

20 / 25

- 2) 4周，皮肤中的类胡萝卜素水平将增加15%，支持胶原蛋白[3,4]。
3) 12周，皮肤光滑度、弹性、干燥度等有改善[2,5]。
4) 16周，皮肤中的类胡萝卜素水平将提高31%，从而改善肤色、亮度、光泽，并减少细纹和皱纹的出现[5]。
产品为美国原装进口，保税仓直邮发货。

参考文献：

- [1]doi:10.4172/2167-065X.1000195
[2]doi:186.1475/2891-13-70
[3]doi:3390.26071931
[4]doi:10.4172/2167-065X.1000195
[5]doi:3390.13072220/nu

注：*个人结果可能有所不同。此时间表可能与典型用户的体验不同，并不代表或保证每个用户都会获得相同或相似的结果。



Mosaic 胶原蛋白支持

可补充皮肤水分，减少细纹和皱纹，改善肤质
扫描右侧小程序码购买



扫码查看

5.健康咨询类项目说明

以下项目属于健康咨询类服务，不作为体检诊断项目，仅作为参考，评测结果将以独立的报告形式呈现。本体检报告不包含独立检测项目

★ iCare+骨力宝-左侧+右侧膝关节正位健康评估（iKangAI+）

项目说明

基于正位X线的人工智能左膝+右膝骨关节炎的健康筛查



下载爱康APP
随时随地看报告

6.医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是屈光不正？



在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫正近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫正远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫正散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。

什么是甘油三酯？



常有人将血脂与甘油三酯视为一体，实际上，甘油三酯（TG）仅是血脂的一种，血脂还包括其他物质如胆固醇等。当病人的血甘油三酯特别高（颗粒大、密度低的脂蛋白过多）时，血液会呈乳白色，将这种血静置一段时间后，血的表面会形成厚厚的一层奶油样物质，这便是化验单上报告的所谓的“甘油三酯”。甘油三酯的功能与胆固醇截然不同，甘油三酯是人体主要的能量储存库。尽管甘油三酯有诸多生理功能，但凡事物极必反，过多的甘油三酯会导致脂肪细胞功能改变和血液粘稠度增加，并增加患冠心病的危险性，而且，血液中甘油三酯过高还会引起急性胰腺炎。

什么是γ-谷氨酰转移酶？

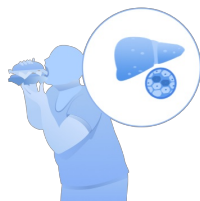


γ-谷氨酰转移酶（γ-GT）是谷氨酰循环的重要酶系之一，参与氨基酸的吸收、转运及利用等。由于γ-GT主要来源肝脏，因此γ-GT活性升高是诊断肝脏疾病生化指标之一。在心血管疾病中测定γ-GT活性变化，主要用于判断急性心肌梗死（AMI）后梗死部位心肌修复情况，以及对心功能不全的诊断等。



下载爱康APP
查看彩色报告

什么是脂肪肝？



构。

指肝脏内脂肪含量增多，过度充积于肝细胞内超过正常范围。脂肪充盈于肝细胞内可减弱其功能，易受亲肝性毒物所损害，甚至发展为肝硬化。脂肪肝为可逆性，在合理治疗后可恢复正常。因此早期诊断有重要临床意义。大多数脂肪肝患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。B超、CT有辅助诊断意义，确诊必须依靠肝活检。脂肪肝形成原因包括饮食不当、长期大量饮酒、过度肥胖等。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结

什么是体重指数？



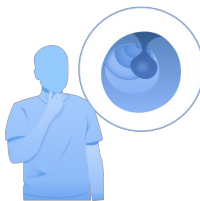
目前常用的体重指数（body mass Index）简称BMI，又译为体质指数。在判断肥胖程度时，使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响，以便于人群或个体间比较。研究表明，大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性，能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性，如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人，体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比，肌肉组织的减少较多，计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量（体脂%）会有助于判断肥胖程度。

什么是低密度脂蛋白胆固醇增高？



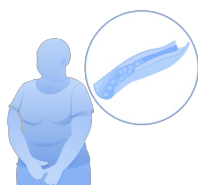
低密度脂蛋白（LDL）是血液中胆固醇含量最多的脂蛋白。当LDL过量时，它携带的胆固醇积存在动脉壁上，易造成动脉硬化，引发冠心病。因此，低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）普遍称为“坏胆固醇”。低密度脂蛋白胆固醇增高能够引起冠心病、脑卒中和外周动脉病，甚至诱发脂肪肝。低密度脂蛋白胆固醇增高常见于冠心病、家族性高胆固醇血症、高脂蛋白血症、急性心肌梗死、甲状腺功能减退症、肾病综合征、阻塞性黄疸、肥胖症以及应用β受体阻滞剂、糖皮质激素等药物。低密度脂蛋白胆固醇增高考虑血脂异常，及时到心内科就诊，明确检查引起低密度脂蛋白胆固醇增高的原因及重要器官的功能状态；积极治疗原发病和并发症；定期复查；改变饮食习惯，加强运动。

什么是息肉？



在致炎因子或某种其他因素长期刺激下，局部粘膜上皮、腺体及肉芽组织增生形成。一般发生在消化道、呼吸道、泌尿道等腔道器官内。它自粘膜表面向管腔内突出形成肉样肿块。息肉大小不等，表面光滑，一般无乳头生成，有的可伴有水肿、继发感染和溃疡形成。按发生原因，息肉可分为增生性和腺瘤性两类。增生性息肉又称炎性息肉，即通称的“息肉”。腺瘤性息肉可为新生的肿瘤，多属良性。

■ 什么是总胆固醇增高？



总胆固醇是指血液中所有脂蛋白所含胆固醇之总和，包括游离胆固醇和胆固醇酯。血清总胆固醇水平与年龄、家族、性别、饮食、精神、遗传等多种因素有关。总胆固醇增高的原因包括高脂蛋白血症、糖尿病、甲状腺功能减退症、胆汁淤积性黄疸、类脂性肾病、肾病综合征等疾病，长期吸烟、饮酒、精神紧张等也会引起总胆固醇增高。总胆固醇轻度增高时临床症状不显著或无临床症状，明显升高时有不同程度的头晕、肢体麻木等症状。胆固醇是动脉粥样硬化的重要危险因素之一。总胆固醇增高考虑血脂异常，建议及时复查，改变饮食习惯，加强体育锻炼，防止发生动脉粥样硬化等疾病；对于已经伴有血脂升高、动脉硬化或者有冠心病、中风家族史者及时到内科就诊，预防心脑血管疾病的发生；养成定期体检的习惯，全面检测血脂。

■ 什么是丙氨酸氨基转移酶增高？

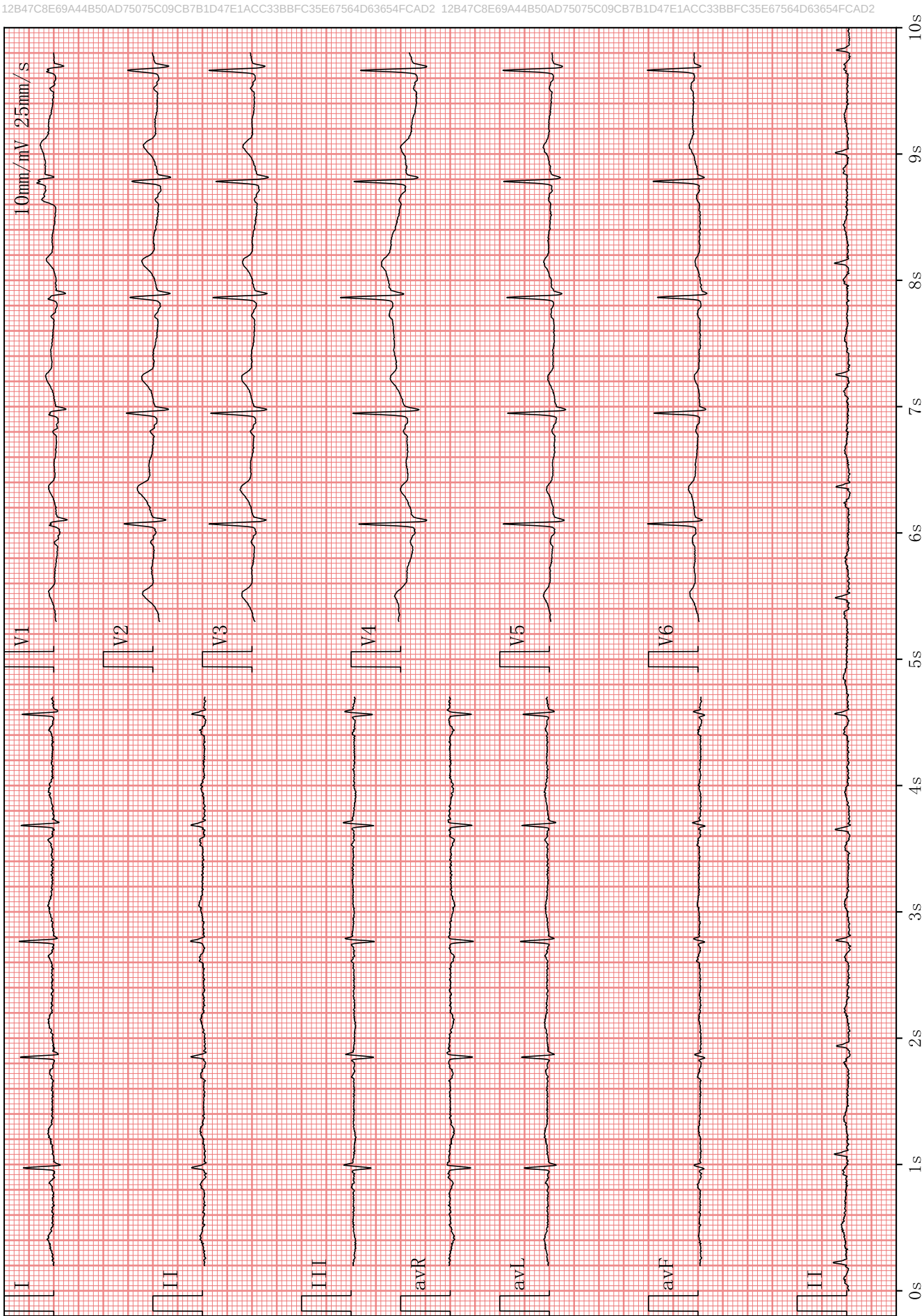


丙氨酸氨基转移酶主要存在于肝细胞的胞质中，体内其他脏器组织，如心肌、骨骼肌、肾、脑等也有此酶，当这些组织损伤或坏死时，该转移酶从细胞中释放入血液，导致丙氨酸氨基转移酶活力增高。丙氨酸氨基转移酶是肝胆疾病的酶学重要诊断指标，当肝脏发生炎症、坏死、中毒等损害，可引起不同程度的丙氨酸氨基转移酶增高。丙氨酸氨基转移酶增高还见于胆管炎、胆囊炎、心肌梗死、内分泌疾病、胰腺疾病、糖尿病、甲状腺功能亢进、严重烧伤、休克、药物中毒等。因此可知，丙氨酸氨基转移酶可以作为反映肝功能的一项重要指标，但是不能只凭丙氨酸氨基转移酶增高作出病因诊断，应结合病史、B超及有关化验，结合各种肝炎病毒标志物的检测结果进行综合分析。当丙氨酸氨基转移酶轻度增高时，如无任何基础疾病，建议排除生理性增高的原因后再复查一次；如果肝脏酶学普遍增高，建议及时到消化内科或者传染科就诊。

体检号:7020251126218

客户信息:蒋德铭/男/45

HR: 68bpm
RR: 878ms
SV1+RV5: 1.09mV
SV1/RV5: 0.17/0.92mV
PR: 144ms
QRS: 96ms
QT/QTc: 399/425ms
P/QRS/T: 0° /1° /51°



12B47C8E69A44B50AD75075C09CB7B1D47E1ACC33BBFC35E67564D63654FCAD2 12B47C8E69A44B50AD75075C09CB7B1D47E1ACC33BBFC35E67564D63654FCAD2

检查时间: 2025-11-26 09:06:48

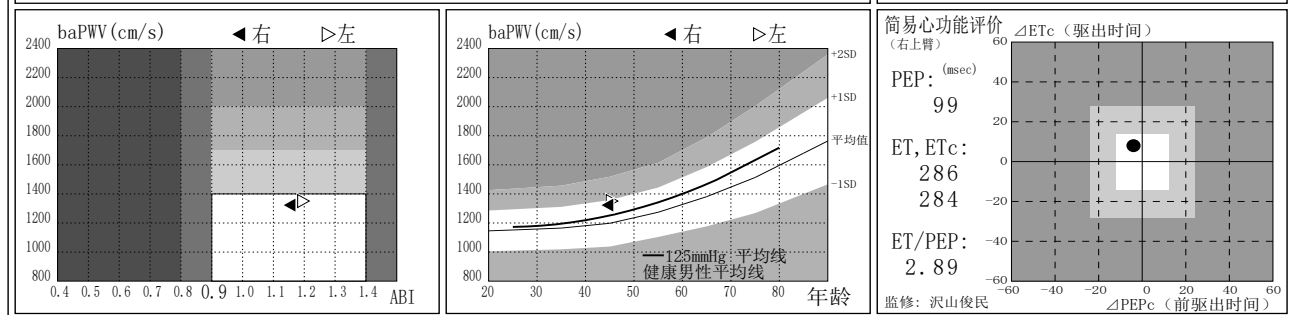
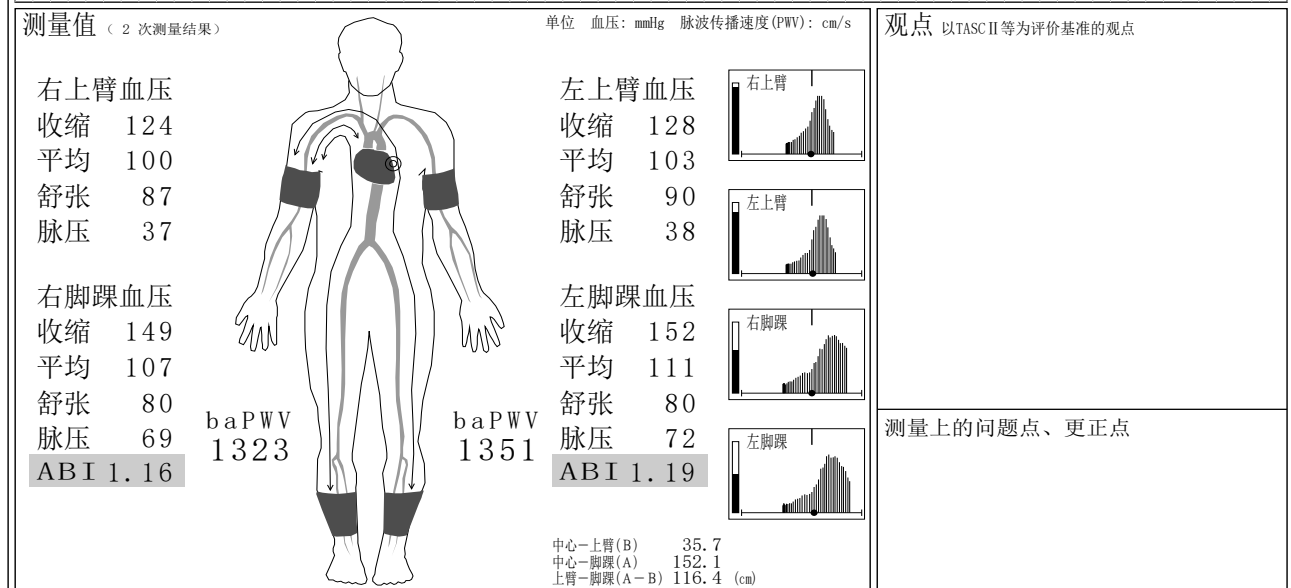
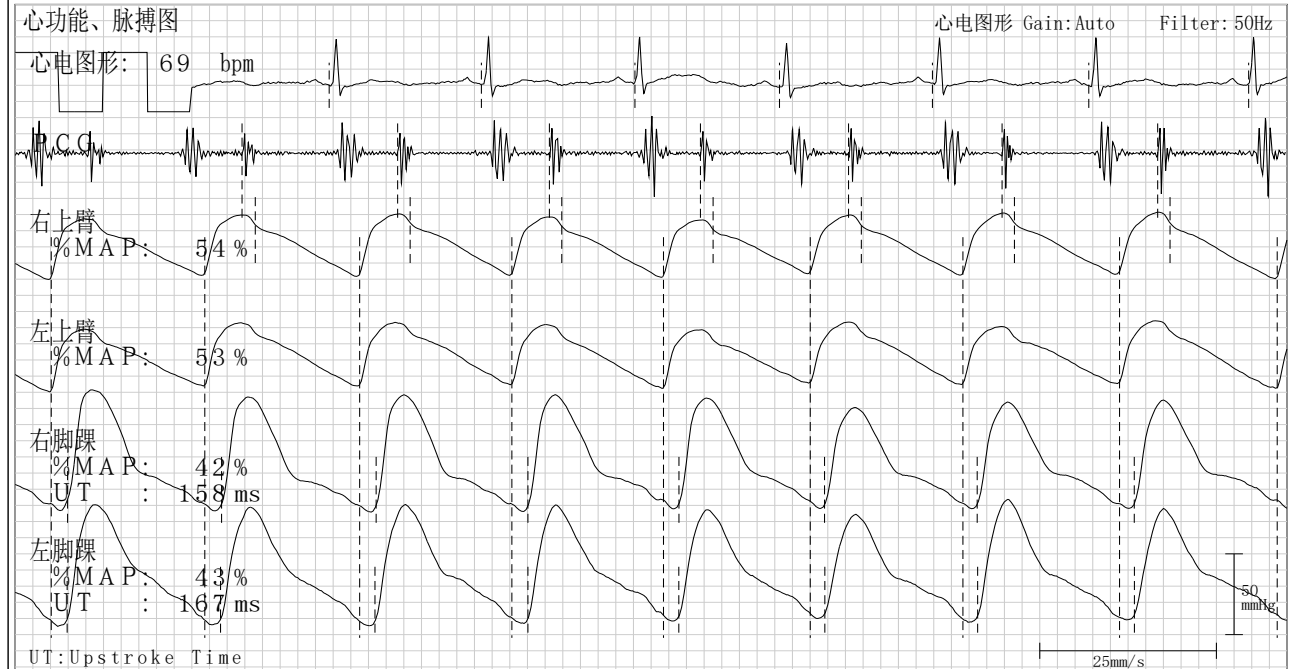
诊断医生

成子

动脉硬化检测分析结果(0r)

检查日期:2025年11月26日 10时37分

ID: 7020251126218	年龄: 45 岁	基础疾病:	医生: 华春兰
姓名: 蒋德铭	身高: 172 cm	体重: 83.0 kg	测量者: 华春兰
科室:	性别: 男性	腹围: --- cm	室温 (°C)
	BMI: 28.1		



SN:02004685 Ver. F3AC. 2. 7. 04-2. 3. 00 L2

检查日期：2025年11月26日10时37分

你现在的
血管状况

姓名：蒋德铭

ID：7020251126218

医生：华春兰

年龄：45岁

身高：172 cm

基础疾病：

BMI：28.1

体重：83.0 kg

腹围：cm

下肢血管堵塞状况（ABI）

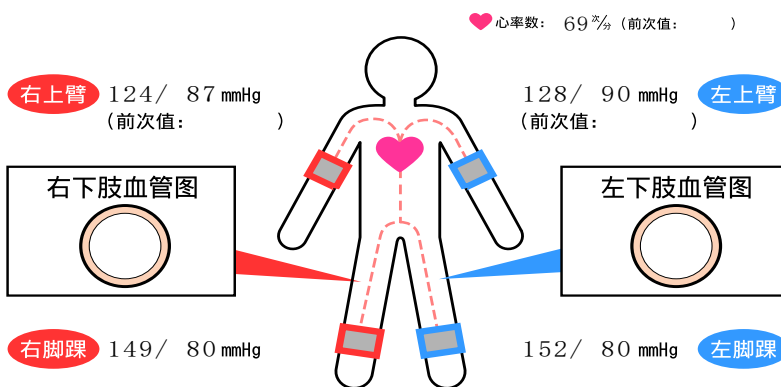
ABI检查

本次检查结果在

正常范围

内。

ABI正常范围（0.91~1.40）

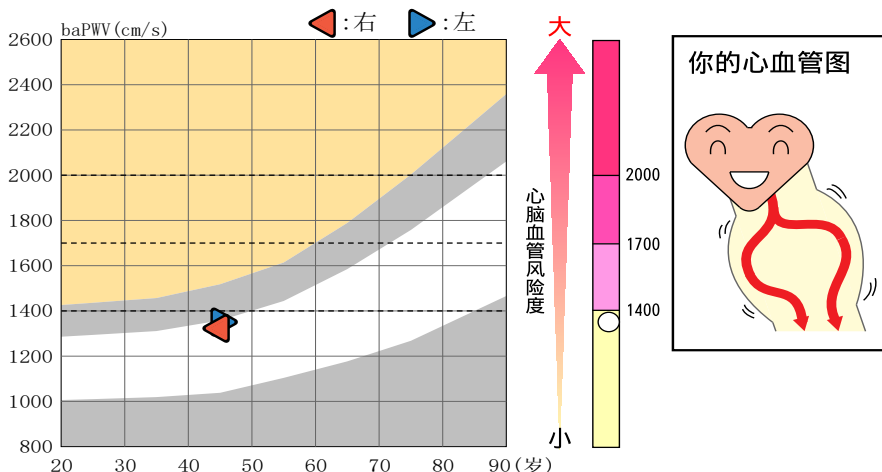
ABI 右下肢 1.16（前次值：）
左下肢 1.19（前次值：）

心脑血管风险度

baPWV检查

本次的检查结果
与健康的45岁男性相比

标准范围

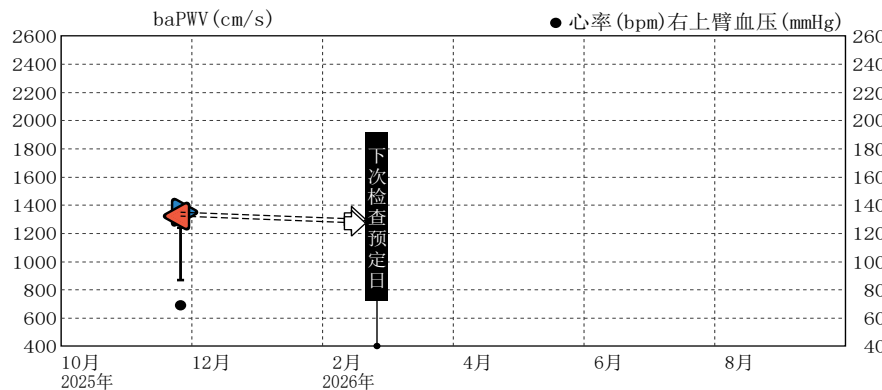
baPWV 右：1323（前次值：）
(cm/s) 左：1351（前次值：）

趋势图

请定期接受血管检查。

下次检查预定日

2026年 2月 日



动脉硬化检测分析结果 [患者用] 2 不可以自己判断检查结果，请咨询医生。

※检查结果的图解释、和实际状态的不一样。
SN:02004685 Ver.F3AC.2.7.04-2.3.00 L2